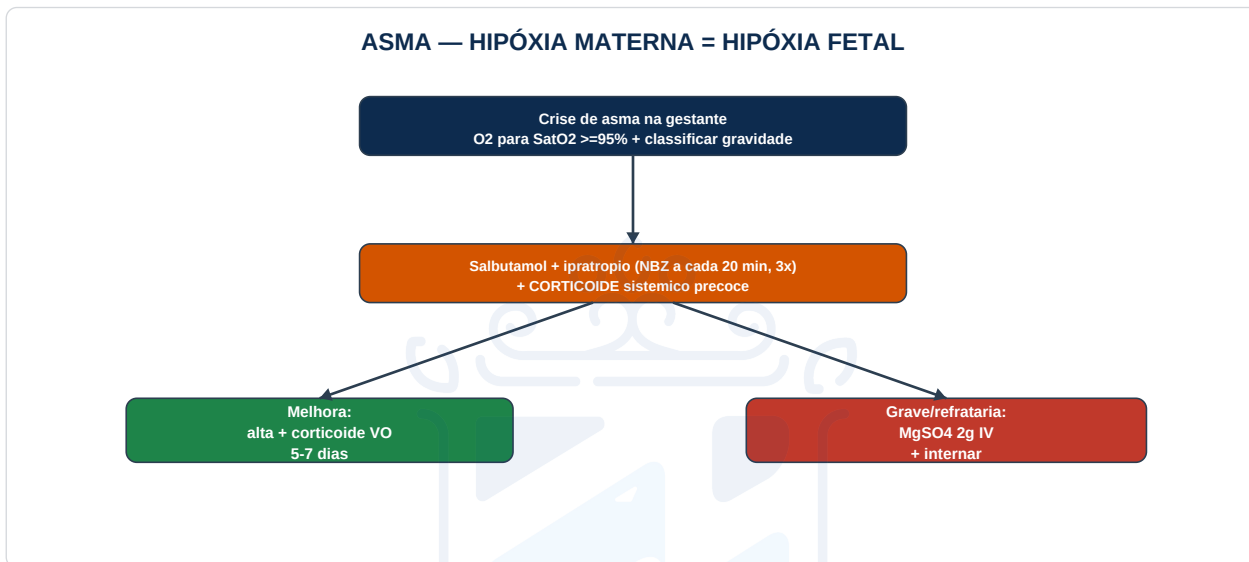


ASMA NA GESTANTE — TRATAR COMO NÃO GESTANTE

FLUXOGRAMA — CRISE NA GESTANTE



PRINCÍPIOS

FUNDAMENTOS

- HIPÓXIA MATERNA = HIPÓXIA FETAL — não subtratar por medo da medicação
- Tratar a crise COMO em não gestante
- As medicações habituais da asma são SEGURAS na gestação
- Objetivo: SatO2 >= 95%

CLASSIFICAÇÃO DA CRISE

Gravidade	Fala / FR	SatO2
Leve	Frases completas; FR < 25	>= 95%
Moderada	Frases curtas, musculatura acessória; FR 25-30	90-94%
Grave	Palavras isoladas; FR > 30; pico de fluxo < 50%	< 90%
Iminência de parada	Silêncio auscultatório, rebaixamento, bradipneia, hipercapnia	—

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

Rx BRONCODILATADOR + CORTICOIDE

O2 suplementar (máscara com reservatório 10-15 L/min) para manter SatO2 >= 95%

Salbutamol NBZ 2,5-5 mg, repetir a cada 20 min (3 doses na 1a hora) ou contínuo se grave

Associar Ipratrópio 0,5 mg NBZ a cada 20 min (3 doses)

CORTICOIDE sistêmico PRECOCE: Prednisona VO 40-60 mg OU Hidrocortisona 100 mg IV 6/6h OU Metilprednisolona 60-125 mg IV (seguro na gestação)

Crise grave/refratária: Sulfato de magnésio 2 g IV em 20 min

Adrenalina IM 0,3-0,5 mg (1:1000) se broncoespasmo grave/anafilaxia

O QUE EVITAR / RED FLAGS

CUIDADOS

- EVITAR: sedativos, AINEs (se asma sensível), restrição excessiva de O₂, ATRASAR o corticoide
- Iminência de parada respiratória (silêncio auscultatório, rebaixamento, bradipneia, hipercapnia) = via aérea/IOT
- Avaliação FETAL: BCF se > 20 semanas; cardiotocografia se viável e crise grave
- Gasometria arterial se grave; RX de tórax se suspeita de complicação (NÃO contraindicado)
- Não retardar a corticoterapia — reduz recaída e internação

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: falha após 1-2h de tratamento, SatO₂ < 95% persistente, pico de fluxo < 60%, asma grave prévia, necessidade de O₂ contínuo
- ☐ ALTA: assintomática/sintomas leves, SatO₂ ≥ 95% em ar ambiente, pico de fluxo > 70%
- ☐ Prescrever na alta: corticoide VO 5-7 dias + broncodilatador de resgate + ajuste da manutenção
- ☐ Orientar retorno imediato se piora; reforçar adesão à manutenção (segura na gestação)
- ☐ Complicações: hipóxia fetal, parto prematuro, baixo peso ao nascer

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Gestante ____ semanas em crise de asma ____ (leve/moderada/grave); SatO₂ ____; FR ____; pico de fluxo ____.
- Tratamento: salbutamol+ipratrópio NBZ, corticoide ____, MgSO₄ se grave.
- Resposta: ____; BCF/CTG: ____.
- Solicito vaga (UTI se iminência de parada) + acompanhamento obstétrico.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Gestante de 28 semanas em crise de asma moderada. Sobre o tratamento, é correto:

- A) Reduzir as doses por medo de teratogenicidade
- B) Tratar como em não gestante: O₂ (SatO₂ ≥ 95%), salbutamol + ipratrópio e corticoide sistêmico precoce (seguros na gestação)
- C) Evitar corticoide na gestação
- D) Usar apenas oxigênio
- E) Iniciar antibiótico empírico

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Por que a hipóxia materna deve ser corrigida agressivamente na asma da gestante?

- A) Porque não tem relação com o feto
- B) Porque hipóxia materna = hipóxia fetal (risco fetal direto)
- C) Porque a gestante tolera melhor a hipóxia
- D) Porque o oxigênio é teratogênico
- E) Porque a SatO₂ ideal é 85%

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual a meta de saturação de oxigênio na crise de asma da gestante?

- A) SatO₂ ≥ 85%
- B) SatO₂ ≥ 95%
- C) SatO₂ ≥ 88%
- D) SatO₂ ≥ 90%
- E) Não há meta definida

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Na crise grave/refratária de asma na gestante, qual medicação endovenosa pode ser usada?

- A) Sedativo benzodiazepínico
- B) Sulfato de magnésio 2 g IV em 20 minutos
- C) AINE endovenoso
- D) Furosemida
- E) Anti-histamínico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual conduta deve ser EVITADA na crise de asma da gestante?

- A) Corticoide sistêmico precoce
- B) Atrasar o corticoide e usar sedativos
- C) Oxigênio suplementar
- D) Salbutamol nebulizado
- E) Avaliação fetal

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A crise de asma na gestante é tratada COMO em não gestante: O₂ para SatO₂ $\geq$ 95%, salbutamol + ipratrópio e corticoide sistêmico precoce — todos seguros na gestação. Subtratar por receio de teratogenicidade é erro grave.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Hipóxia materna se traduz em hipóxia fetal; por isso a oxigenação e o controle da crise devem ser agressivos, com meta de SatO₂ $\geq$ 95%.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A meta é SatO₂ $\geq$ 95% na gestante, mais rigorosa que no adulto não gestante, pela vulnerabilidade fetal à hipóxia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Na crise grave/refratária pode-se usar sulfato de magnésio 2 g IV em 20 min (efeito broncodilatador adjuvante). Sedativos são contraindicados na crise asmática.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Deve-se evitar atrasar o corticoide e usar sedativos; também se evitam AINEs (se asma sensível) e a restrição excessiva de oxigênio. Corticoide, O₂ e broncodilatador são pilares.

SM24
Suporte ao Plantão Médico